

甲磺酸帕珠沙星的药物相互作用与配伍禁忌

姜芳宁

【摘要】目的：通过综述甲磺酸帕珠沙星的药物相互作用与配伍禁忌，为临床用药提供参考依据。方法：阅读甲磺酸帕珠沙星的药品说明书和查阅国内医药学相关资料，将文献中报道的甲磺酸帕珠沙星的药物相互作用以及与其他药物产生的配伍禁忌进行综述。结果：甲磺酸帕珠沙星与多种药物存在相互作用及配伍禁忌。结论：医护人员应重视甲磺酸帕珠沙星的药物相互作用与配伍禁忌，以保证用药安全性。

【关键词】甲磺酸帕珠沙星；药物相互作用；配伍禁忌

甲磺酸帕珠沙星为新一代喹诺酮类抗菌药，为类白色或微黄色的澄明液体，其主要作用机制是抑制细菌DNA的合成和复制而导致细菌死亡，具有抗菌谱广、抗菌作用强的特点，适用于由敏感菌引起的各种感染，临床用于治疗革兰阳性菌及阴性菌引起的呼吸道感染、泌尿生殖系统感染、皮肤软组织感染及外科感染^[1]。是目前临床常用的抗菌药物之一，单独使用时未发现明显的配伍禁忌，在现有的静脉用配伍禁忌表中未查找到甲磺酸帕珠沙星相应的药物配伍，为此，笔者通过阅读其药品说明书和查阅相关医药学资料，将文献中报道的甲磺酸帕珠沙星的药物相互作用以及与其他药物产生的配伍禁忌进行综述，旨在为临床用药提供参考依据。

1 甲磺酸帕珠沙星与其他药物的相互作用

1.1 甲磺酸帕珠沙星可抑制茶碱在肝脏的代谢，使茶碱的血药浓度升高，可能发生茶碱中毒症状，如胃肠道反应、头痛、心律不齐、痉挛等，所以病人需密切观察，两药合用时应密切观察茶碱的血药浓度。

1.2 甲磺酸帕珠沙星与苯基乙酸类、二乙酰胺类、非类固醇消炎镇痛剂合用时可能发生痉挛，所以应密切观察，如出现症状应立即停药并采取解痉治疗，当出现痉挛时，应终止两药的合用，保持呼吸道畅通，并使用抗痉挛的药物进行治疗。

1.3 甲磺酸帕珠沙星与华法林合用时，可增强华法林的作用，从而延长凝血时间，所以用药时应密切观察并做凝血时间试验。

1.4 甲磺酸帕珠沙星与丙磺酸合用时，血清半衰期延长，

AUC增加，但血药峰浓度无明显变化。

2 甲磺酸帕珠沙星与其他药物的配伍禁忌

2.1 甲磺酸帕珠沙星与呋塞米注射液存在配伍禁忌

王琼报道^[2]在输入甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液过程中，给予呋塞米滴加入壶后液体立即出现白色混浊，立即关闭调节夹更换输液器，患者未出现不良反应。因此，在临床使用时如需同时应用呋塞米利尿，建议先更换其他液体，以免甲磺酸帕珠沙星与呋塞米两种药物直接接触出现混浊。

2.2 甲磺酸帕珠沙星与炎琥宁存在配伍禁忌

唐朝焕报道^[3]在连续静脉输入甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液和炎琥宁氯化钠注射液时，两药在莫非氏滴管内混合立即出现混浊，并产生淡黄色絮状沉淀，立即更换输液器并用其他药物间隔滴注，更换下的输液器静置8 h，淡黄色沉淀仍未消失，说明两药存在配伍禁忌。

2.3 甲磺酸帕珠沙星与碳酸氢钠存在配伍禁忌

万小超报道^[4]在甲磺酸帕珠沙星与碳酸氢钠注射液相邻输注时，发现在莫非氏滴管内立即出现白色浑浊，并有白色絮状沉淀产生，考虑为配伍反应，并通过进一步配伍试验观察得到证实。

2.4 甲磺酸帕珠沙星与红花黄色素存在配伍禁忌

门玉枫等报道^[5]在连续输入甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液并红花黄色素氯化钠注射液时，在莫非氏滴壶内立即出现白色混浊，并出现絮状沉淀，按上述方法重复多次，均出现相同反应，说明两者存在配伍禁忌。

2.5 甲磺酸帕珠沙星与痰热清存在配伍禁忌

吕会玲^[6]、陈洪亮等报道^[7]甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液静脉滴注后，续滴5%葡萄糖注射液内加入痰热清注射液的溶液，输液管内出现浑浊及絮状物。为了进一步证实甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液与痰热清注射液之间的配伍禁忌，按上述方法将两药直接混合，出现相同反应，说明两者存在配伍禁忌。

2.6 甲磺酸帕珠沙星与夫西地酸钠存在配伍禁忌

尉雪梅等报道^[8]甲磺酸帕珠沙星与夫西地酸钠这两种药物的氯化钠注射液连续输注时，立刻在输液管中出现白色絮状物。再取两种药物的氯化钠注射液，互换前后输注

作者单位：735100 甘肃省嘉峪关市酒钢医院



顺序, 实验结果一样。说明两者存在配伍禁忌。

2.7 甲磺酸帕珠沙星与磷酸钠氯化钠注射液存在配伍禁忌

陈晓吟等报道^[9]在磷酸钠与甲磺酸帕珠沙星连续输注时, 输液器管道中立刻出现白色混浊, 立即停止输液并更换输液器, 用生理盐水冲管后再输注甲磺酸帕珠沙星, 没有再出现白色混浊。取磷酸钠氯化钠溶液和甲磺酸帕珠沙星氯化钠溶液各5 ml在无菌干燥试管中混合, 也出现白色混浊, 静置30 min仍有白色混浊, 判断发生了化学反应形成了不溶性混合物。

2.8 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠与甲磺酸帕珠沙星存在配伍禁忌

王丽娜报道^[10]在临床用药时发现阿莫西林钠舒巴坦钠与甲磺酸帕珠沙星连续输注时, 莫非氏滴管内立即出现白色絮状物, 放置24 h不消失。注射用阿莫西林钠舒巴坦钠与酸性制剂混合时会发生沉淀, 而甲磺酸帕珠沙星注射液中含有羧酸结构, 为弱酸性。为保证药效, 临床应用这两种药物时, 应避免连续使用, 或用其它液体间隔, 避免发生不良反应。

3 讨论

随着现代医学的发展, 新型药物的不断出现, 临床联合用药静脉滴注过程中难免会出现配伍禁忌, 甲磺酸帕珠沙星化学结构中存在羧酸结构, 具有酸的性质, 与碱性药物如碳酸氢钠、阿莫西林钠舒巴坦钠等注射剂混合时会因pH值的改变发生化学反应, 析出结晶。临床医护人员在工作中要仔细、认真、科学、合理地安排输液顺序, 遇有配伍禁忌的两药连续使用时, 在两组液体之间输入适量0.9%氯化钠注射液, 冲净输液管内残余药物, 再更换另一

组液体, 护理人员在平时临床工作中应做到勤观察、勤巡视, 一旦发现异常要及时处理, 可避免发生不良反应, 提高临床用药的安全性。

现在抗菌药物种类越来越多, 一般都有商品名和通用名两种, 这给临床用药发现配伍禁忌增加了难度。经查阅文献, 有关甲磺酸帕珠沙星与其他药物相互作用的报道甚少, 有待于进一步的临床观察和总结。

参考文献

- [1] 朱广淑, 王集会, 王秀斌. 帕珠沙星[J]. 山东医药工业, 2003, 22(1):59.
- [2] 王琼. 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液与呋塞米注射液存在配伍禁忌[J]. 实用心脑血管病杂志, 2008, 16(11):16.
- [3] 唐朝焕. 甲磺酸帕珠沙星与炎琥宁存在配伍禁忌[J]. 华北国防医药, 2007, 19(4):15.
- [4] 万小超. 甲磺酸帕珠沙星注射液与碳酸氢钠存在配伍禁忌[J]. 华北国防医药, 2007, 19(6):9.
- [5] 门玉枫, 宗爱华, 安丹. 甲磺酸帕珠沙星与红花黄色素存在配伍禁忌[J]. 医学理论与实践, 2008, 21(10):1141.
- [6] 吕会玲. 痰热清与甲磺酸帕珠沙星存在配伍禁忌[J]. 中国误诊学杂志, 2008, 8(29):7147.
- [7] 陈洪亮, 胡冬梅. 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液与痰热清存在配伍禁忌[J]. 护理学报, 2008, 15(5):74.
- [8] 尉雪梅, 孙巍, 杜伟. 夫西地酸钠与甲磺酸帕珠沙星存在配伍禁忌[J]. 护理研究, 2008, 22(5):1300.
- [9] 陈晓吟, 林壬娇, 丘小珊, 等. 磷酸钠氯化钠与帕珠沙星存在配伍禁忌[J]. 护理学报, 2008, 15(2):7.
- [10] 王丽娜. 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠与甲磺酸帕珠沙星存在配伍禁忌[J]. 护理实践与研究, 2005, 2(5):45.

氯沙坦钾氢氯噻嗪治疗高血压患者降压疗效分析

曲福生

氯沙坦钾氢氯噻嗪(商品名: 海捷亚)是血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂复方降血压制剂, 每片含氯沙坦钾50 mg和氢氯噻嗪12.5 mg, 从理论上讲两者具有降压协同作用, 又有互相抵消不良反应的好处。为评价氯沙坦钾氢氯噻嗪的降压效果, 本文对60例高血压患者进行了观察, 现将结果报道如下:

作者单位: 835000 新疆伊犁州边防支队卫生队

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组60例, 为2008年5月至11月我院住院和门诊待手术病人中的1级、2级高血压患者, 其中男性38例, 女性22例, 年龄30岁~69岁, 平均51岁。28例是新发现的高血压, 32例曾不规则间断服用过钙拮抗剂、利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂, 受体阻滞剂或复方降压片。所有患